Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
4ª Vara Cível Residual

Processo: 0810399-47.2020.8.12.0001
Autos: Procedimento Comum Cível
Autor: Janaina Santos Mecchi
Réu: Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico

Vistos etc.

Trata-se de *Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Obrigação de Fazer* proposta por **Janaína Santos Mecchi** contra **Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico**, partes devidamente qualificadas nos autos.

Relata, a parte autora, que é usuária de plano de saúde da ré desde 28/07/2018 e que, em dezembro de 2019, descobriu estar grávida e foi diagnosticada com trombofilia por deficiência de proteína S (CID: D68.9), conforme laudo médico de sua ginecologista credenciada do plano, a qual lhe prescreveu aplicação diária de 01 (uma) ampola do medicamento Clexane 40 mg (Enoxoparina), durante todo o período de gestação e por mais de quarenta dias após o parto.

Disse ter sido informada pela ré que o tratamento não seria custeado pelo plano de saúde, por se tratar de procedimento *home care*, mas apenas seria concedido um desconto de 50% no valor do medicamento.

Contou que uma caixa com 10 (dez) ampolas custa em média R$ 630,74 (seiscentos e trinta reais e setenta e quatro centavos), inviabilizando sua aquisição, uma vez que o custo mensal do tratamento ficaria em torno de R$ 1.892,22 (mil oitocentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos), cujo custo total chega a importância de R$ 26.491,08 (vinte e seis mil, quatrocentos e noventa e um reais e oito centavos).

Frisou a necessidade do medicamento porque, segundo o laudo médico realizado por sua médica, as complicações obstétricas decorrentes da enfermidade que acomete a autora constituem 75% das causas de morbidade e mortalidade neonatal, situação esta agravada no caso da requerente, que possui histórico de parto prematuro em razão de pré-eclâmpsia grave.

Requereu, desta forma, a concessão da tutela de urgência para determinar todo custeio do tratamento seja feito integralmente pela requerida e, no mérito, seja declarada abusividade das cláusulas contratuais que obstam o direito da autora ao tratamento adequado para enfermidade diagnosticada, além de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.261,92 (dois mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos), pela compra parcial dos medicamentos utilizados em seu tratamento, bem como a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Juntou documentos de f. 15-79 e protestou pela justiça gratuita.

Decisão de f. 87-94, oportunidade em que foram concedidos à autora as benesses da gratuidade judicial e a tutela provisória de urgência na forma pretendida.

Ofício encaminhado pelo TJ/MS, informando o recebimento do

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 21/09/2021 às 22:44 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0810399-47.2020.8.12.0001 e código bxtBhaUu.

recurso de agravo de instrumento manejado pela ré em ambos os efeitos (devolutivo e suspensivo) – f. 150-156.

Contestação ofertada pela ré, oportunidade em que alegou a impossibilidade do fornecimento de medicamento diante da ausência de previsão no rol da ANS que obriga a requerida a custeá-lo, bem como, ausência de previsão contratual e a consequente legalidade da negativa.

Defende a inocorrência de danos morais e materiais na espécie.

Requer a improcedência dos pedidos iniciais (f. 161-192).

Juntada de ofício comunicando decisão preferida no recurso de agravo de instrumento interposto pela ré, com o seu provimento, reformando-se a decisão que deferiu a tutela antecipada de urgência (f. 324-336).

Impugnação à contestação de f. 337-349, repisando o pedido de procedência formulado na inicial.

Determinada a intimação das partes para especificação das provas pretendidas (f. 356), a requerente pediu a produção de prova testemunhal (f. 359-360), enquanto a ré protestou pela produção de prova testemunhal e documental (f. 361-363).

Decisão saneadora, fixou os pontos controvertidos da demanda, indeferiu o pedido de prova testemunhal formulado pelas partes e deferiu a produção de prova documental requerida pela ré (f. 364-367).

Certidão em que noticia a estabilização da decisão saneadora (f. 370).

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de *Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Obrigação de Fazer* proposta por **Janaína Santos Mecchi** contra **Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico**, partes devidamente qualificadas nos autos.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra e de forma antecipada, já que a prova testemunhal requerida pelas partes foi indeferida, não havendo insurgência da decisão saneadora quanto a este tópico.

Logo, por inexistirem preliminares para serem analisadas, passo a proferir sentença de mérito, nos termos do artigo 355, I, do CPC.

Obrigação de Fazer; nulidade de cláusulas contratuais e indenização por danos materiais e morais

Como visto, a requerente foi diagnosticada com trombofilia por

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 21/09/2021 às 22:44 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0810399-47.2020.8.12.0001 e código bxtBhaUu.

deficiência da proteína S (CID: D68,9) e defende que a negativa de cobertura do plano de saúde em fornecer o medicamento *Clexane 40mg* (Enoxaparina), durante toda sua gestação e por mais quarenta dias após o parto é indevida, já que o rol da ANS é exemplificativo e não taxativo, fazendo jus, portanto, à indenização material e moral pelos prejuízos suportados.

Inicialmente, é de se ressaltar que esse juízo adotava o entendimento quase majoritário da jurisprudência pátria no sentido de que o rol da ANS (Agência Nacional de Saúde) para fornecimento do fármaco *Clexane 40mg* (Enoxaparina) para pacientes usuárias do plano de saúde, portadoras de *trombofilia* com ausência de proteína "S", era exemplificativo e não taxativo, e por isso, a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde em fornecer o tratamento médico domiciliar prescrito pelo médico assistente era abusiva, ilícita e gerava o dever de indenizar.

No entanto, após detida análise dos recursos que foram promovidos contra tais decisões, constatamos que nosso E. Tribunal de Justiça, atualmente, vêm adotando posicionamentos aliados ao novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "*É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim.*" vg, (**REsp 1.692.938/SP**, 3ª Turma, julgado em **27/4/2021**, DJe 4/5/2021; e **REsp 1.883.654/SP**, Quarta Turma, julgado em **08/06/2021**, DJe 02/08/2021).

Nesse novo panorama, inclusive, foi a decisão proferida em sede do Recurso de Agravo de Instrumento (**Autos n. 1404724-57.2020.8.12.0000**), interposto pela ré contra nossa decisão que havia concedido a tutela de urgência provisória em favor da autora, à época. Vejamos (f. 324-336):

30 de junho de 2020

4ª Câmara Cível

Agravo de Instrumento - Nº 1404724-57.2020.8.12.0000 - Campo Grande
Relator – Exmo. Sr. Des. Vladimir Abreu da Silva
Agravante : Unimed Campo Grande MS - Cooperativa de Trabalho Médico
Advogado : Wilson Carlos de Campos Filho (OAB: 11098/MS)
Advogado : Clélio Chiesa (OAB: 5660/MS)
Agravada : Janaina Santos Mecchi
Advogado : Edlaine Naiara Loureiro Valiente (OAB: 21263/MS)
Advogado : Edson Kohl Junior (OAB: 15200/MS)
Advogada : Kamila dos Santos Lemos de Oliveira (OAB: 22441/MS)

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUSÃO PREVISTA NO CONTRATO E NA LEI Nº 9.656/98 – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO RECLAMADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a concessão da tutela provisória de urgência, necessário se faz que a parte comprove a probabilidade do direito reclamado, assim como o perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Tratando-se de medicamento de uso domiciliar para o tratamento de doença diversa do câncer, não está a operadora de saúde agravante obrigada a custeá-lo, em virtude de expressa disposição legal e contratual.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, Por unanimidade, com o parecer, deram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Campo Grande, 30 de junho de 2020.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 21/09/2021 às 22:44 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0810399-47.2020.8.12.0001 e código bxtBhaUu.

Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
4ª Vara Cível Residual

Constou ainda do voto, a seguinte fundamentação:

Ocorre que, em se tratando de fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, há de se observar, além do contrato firmado entre as partes, o que dispõe a Lei nº 9.656/98 sobre a cobertura mínima obrigatória que os planos de saúde estão obrigados a cumprir:

> *"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:*
>
> *(...)*
>
> *VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;"*

Já o art. 12, inciso I, "c", e inciso II, "g", reza, que:

> *"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:*
>
> *I - quando incluir atendimento ambulatorial:*
>
> *(...)*
>
> *c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes.*
>
> *II - quando incluir internação hospitalar:*
>
> *(...)*
>
> *g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar."*

Ademais, lê-se da cláusula X do contrato que, *"EM CONFORMIDADE COM O QUE PREVÊ A LEI Nº 9656/98 ESTÃO EXCLUÍDOS DE*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 21/09/2021 às 22:44 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0810399-47.2020.8.12.0001 e código bxtBhaUu.

COBERTURA DO PLANO OS EVENTOS E DESPESAS DECORRENTES DE ATENDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO E OS PROVENIENTES DE:"

Com efeito, tratando-se de medicamento de uso domiciliar para o tratamento de doença diversa do câncer, não está a operadora de saúde agravante obrigada a custeá-lo, em virtude de expressa disposição legal e contratual, conforme, aliás, recentemente decidiu esta 4ª Câmara Cível:

> *"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUSÃO PREVISTA NO CONTRATO E DE ACORDO COM A LEI Nº 9.656/98 E RN Nº 428/2017 DA ANS – AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA – TUTELA CASSADA NESTA PARTE – (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 300, caput, do CPC estabelece que A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se evidencia a probabilidade do direito invocado pela parte autora, tendo em vista que o plano por ela contratado exclui da cobertura ...fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, (VI, art. 20, RN 428/2017, da ANS), seguindo a mesma linha a exclusão contida no inc. VI do art. 10 da Lei nº 9.656/98, devendo ser reformada em parte a decisão que determinou à agravante o fornecimento do medicamento clexane 40mg. (...)" (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1403801-65.2019.8.12.0000, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 31/05/2019, p: 04/06/2019).*

Não se pode olvidar que a prestação do serviço de saúde consistente no fornecimento de fármaco para uso em tratamento domiciliar de doença, *a priori*, não pode ser voltada para operadora de saúde, sob pena de ensejar risco a atividade e a todo o sistema de custeio de tratamentos de doenças, conforme normas e protocolos legais que regem as operadoras particulares de assistência à saúde.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela provisória formulado pela parte autora, ora agravada.

Com efeito, a **2ª Câmara Cível** do TJ/MS, também já alterou o posicionamento antes adotado, agora no sentido de que é lícita a cláusula que exclui obrigatoriedade do fornecimento de medicamento fora do ambiente hospitalar pela operadora do plano de saúde. Confira-se:

> *APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE –* ***FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DO AMBIENTE HOSPITALAR – APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM AMBIENTE DOMICILIAR*** *– RECURSO DE UNIMED DOURADOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – REJEITADA –* ***CLAUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUI A OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – VEDAÇÃO INSERIDA NA LEI Nº 9.656/98 – MOLÉSTIA NÃO INCLUÍDA NAS EXCEÇÕES DA LEI 9.565/98 – DESOBRIGAÇÃO – RESOLUÇÃO NORMATIVA 387/2015 E PARECER TÉCNICO 28/2016 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 21/09/2021 às 22:44 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0810399-47.2020.8.12.0001 e código bxtBhaUu.

*– **SENTENÇA REFORMADA** – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJMS. Apelação Cível n. 0801228-68.2017.8.12.0002, Dourados, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Nélio Stábile, j: **10/02/2021**, p: 17/02/2021)*

De igual forma, o entendimento da **4ª Câmara Cível** do TJ/MS:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUSÃO PREVISTA NO CONTRATO E NA LEI Nº 9.656/98 – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO RECLAMADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para a concessão da tutela provisória de urgência, necessário se faz que a parte comprove a probabilidade do direito reclamado, assim como o perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Tratando-se de medicamento de uso domiciliar para o tratamento de doença diversa do câncer, não está a operadora de saúde agravante obrigada a custeá-lo, em virtude de expressa disposição legal e contratual. (**TJMS**. Agravo de Instrumento n. 1402741-86.2021.8.12.0000, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: **30/04/2021**, p: 10/05/2021)*

O fato é que o Superior Tribunal de Justiça, em recente recurso especial julgado pela **Segunda Seção, REsp n. 1.755.866/SP**, relator Ministro Marco Buzzi, decidiu que a universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado, porquanto, nos termos dos arts. 199 da Constituição Federal e 4º, § 1º, da Lei n. 8.080/1990, a assistência à saúde de iniciativa privada é exercida em caráter complementar, sendo certo que a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente aos contratos a envolver a saúde suplementar.

Isso porque, segundo aquele Órgão Superior, obedece à lógica atuarial, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevada será a contraprestação pecuniária paga pela parte aderente e assim, a saúde suplementar cumpre propósitos traçados em regras legais e infralegais, não estando o judiciário legitimado e aparelhado para interferir, em violação da tripartição de Poderes, nas políticas públicas (**REsp 1.883.654/SP**, Relator **Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO**, Quarta Turma, julgado em **8/6/2021**, DJe 2/8/2021).

Deste modo, ainda que referidas decisões emanadas pelo STJ não tenham sido fixadas em sede de recursos repetitivos de vinculação obrigatória, tenho que se mantivermos o entendimento anteriormente adotado para o caso dos autos, levaria uma expectativa de direito desnecessária à parte demandante da procedência do seu pleito, sendo que, ao final, em última instância, seu pedido estaria fadado à improcedência.

Feito esse pequeno introito, e agora de acordo com o novo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 21/09/2021 às 22:44 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0810399-47.2020.8.12.0001 e código bxtBhaUu.

entendimento adotado por nosso TJMS e pelo STJ, passo a demonstrar os motivos que levam à improcedência do pleito inicial.

Isso porque, da análise da informação do laboratório detentor do registro do **Clexane** (nome comercial da **Enoxaparina**) na bula do paciente registrada na Anvisa[1], o medicamento é apresentado em "*solução injetável de 20 mg/0,2 mL: embalagem com 2 e 10 seringas preenchidas com sistema de segurança; solução injetável 40 mg/0,4 mL: embalagem com 2, 6 e 10 seringas preenchidas com sistema de segurança; solução injetável 60 mg/0,6 mL: embalagem com 2 seringas preenchidas graduadas com sistema de segurança; solução injetável 80 mg/0,8 mL: embalagem com 2 seringas preenchidas graduadas com sistema de segurança; solução injetável 100 mg/1,0 mL: embalagem com 2 seringas preenchidas graduadas com sistema de segurança, para ser administrado por via subcutânea ou intravenosa, cuja via de administração varia de acordo com a indicação do produto*". Além disso, verifica-se que a **técnica de injeção intravenosa é indicada apenas para o tratamento de infarto agudo do miocárdio** com elevação do segmento ST, **o que não é a hipótese da requerente.**

Assim, pela bula do medicamento que é objeto dos autos e para a patologia que acomete a requerente (trombofilia), a aplicação pode ser feita pela própria autora ou **fora do ambiente hospitalar, não necessitando de internação ou de atendimento ambulatorial para sua administração.**

Com efeito, no caso dos autos, de acordo com o laudo médico de f. 21, foi prescrito à autora a aplicação de uma ampola de Clexane, diariamente, durante toda a gestação e 40 dias após o parto; ou seja, **seu uso não exige a intervenção de profissional de saúde habilitado, tampouco se verifica ser a hipótese de o medicamento ser administrado em ambiente ambulatorial ou hospitalar** e, assim, a ré não pode ser responsável pelo fornecimento de medicação, a não ser **quando de internação do paciente,** o que, repita-se, não é o caso dos autos.

É o que se extrai do contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares firmado entre as partes e anexado às f. 25-68, em que resta estabelecido que o plano de saúde contratado da ré **não contempla o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, consoante Cláusula "10.1.23" de f. 45**.

Ainda, têm-se que o contrato em questão foi celebrado na vigência da Lei 9.656/98 e de acordo com a Resolução Normativa 387/2015 e Parecer Técnico 28/2016 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, os quais limitam as coberturas dos planos de saúde aos termos da referida normativa.

O Parecer Técnico nº 28/GEAS/GGRAS/DIPRO/2016[2], da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que trata da cobertura de medicamentos pelos planos de saúde é claro ao estabelecer que "*a Lei nº 9.656, de 1998, deixa explícito que, nos casos de terapia medicamentosa, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não*

[1] fonte disponível em (https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?nomeProduto=CLEXANE, acesso em 20/09/2021).
[2] disponível em (http: / / www . Ans . Gov . Br / images / stories / parecer _ técnico / uploads / parecer _ técnico /_parecer_2016_28.Pdf), acesso em 20/09/2021.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 21/09/2021 às 22:44 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0810399-47.2020.8.12.0001 e código bxtBhaUu.

está contemplado dentre as coberturas obrigatórias (art. 10, inciso VI), exceção feita apenas para os medicamentos ***antineoplásicos orais e para controle de efeitos colaterais e adversos dos medicamentos antineoplásicos*** *(art. 12, inciso I, alínea 'c', e inciso II, alínea 'g')*".

E complementa:

"Quanto aos planos de saúde de segmentação hospitalar (com ou sem obstetrícia), as normas vigentes asseguram cobertura obrigatória para os medicamentos a seguir:

a) Medicamentos administrados durante o período de internação hospitalar, conforme prescrição do profissional assistente (art. 12, inciso II, alínea 'd', da lei 9.656, de 1998, c/c arts. 17,19 e 22, inciso VIII e IX, da RN nº 387, de 2015);

b) (...)

d) Medicamentos prescritos durante a internação domiciliar, caso o oferecimento da internação domiciliar conste em aditivo contratual acordado ou quando, por livre iniciativa, a operadora oferecer em substituição à internação hospitalar art. 12, inciso II, alíneas "d" e "g", da Lei 9.656, de 1998, c/c art. 14, da RN nº 387, de 2015".

Nessa perspectiva, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que tratando-se de medicamento de **uso domiciliar** para o tratamento de doença **diversa de neoplasia maligna (câncer)**, como é o caso destes autos em que a requerente **postula pelo fornecimento de medicamento para tratamento de trombofilia gestacional**, e de acordo com o atual posicionamento adotado pelo STJ nos julgados acima colacionados, não está a operadora do plano de saúde, ora requerida, obrigada a custeá-lo, em virtude de expressa disposição legal e contratual, sob pena de ensejar risco a atividade e a todo o sistema de custeio de tratamentos de doenças, conforme normas e protocolos legais que regem as operadoras particulares de assistência à saúde.

No caso, havendo cláusula expressa no contrato de plano de saúde que exclui o fornecimento de medicamento para **tratamento domiciliar**, é improcedente a pretensão que visa tal cobertura, pois, como forma de manter o equilíbrio econômico financeiro, é lícito o estabelecimento de eventos não cobertos, mesmo porque a atividade ofertada pelas operadoras não tem o objetivo de garantir a saúde de forma ilimitada, integral, universal, sem limites ou restrições.

E assim, o pedido neste ponto é **improcedente**.

Com relação ao pedido indenizatório por danos materiais e morais, de igual forma, entendo não ser devida tal condenação, haja vista que o não fornecimento do fármaco não significa descumprimento de cláusula contratual pactuada, conforme mencionado pela requerente, visto que não é obrigação do plano de saúde o fornecimento, tendo a operadora de plano de saúde agido dentro do que prevê a lei de regência dos planos de saúde e

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 21/09/2021 às 22:44 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 08110399-47.2020.8.12.0001 e código bxtBhaUu.

dentro dos ditames do pacto efetuado entre as partes.

Assim, a **improcedência** destes pedidos também é medida impositiva.

Dispositivo

Diante do exposto, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, **JULGO IMPROCEDENTES** os pedidos formulados nesta ação declaratória e indenizatória proposta por **Janaína Santos Mecchi** contra **Unimed Campo Grande MS – Cooperativa de Trabalho Médico**.

Condeno a requerente ao pagamento das verbas de sucumbência, bem como em honorários advocatícios da parte adversa que, com fulcro no artigo 85, § 2°, do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica diferida, por ser a autora beneficiária da gratuidade judicial (f. 81), conforme prevê o artigo 98, § 3°, do CPC.

Tanto que transitada em julgado, em nada sendo requerido, com as cautelas de estilo, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Campo Grande-MS, *data da assinatura digital*.

Vania de Paula Arantes
Juiz(a) de Direito

Assinado por Certificação Digital

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 21/09/2021 às 22:44 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0810399-47.2020.8.12.0001 e código bxtBhaUu.